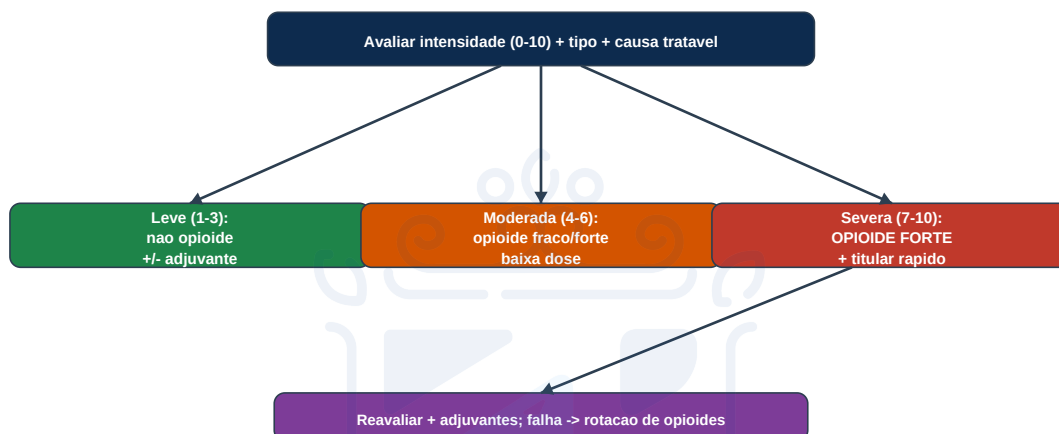


DOR ONCOLÓGICA E ROTAÇÃO DE OPIOIDES

FLUXOGRAMA — ESCADA ANALGÉSICA ADAPTADA

DOR ONCOLÓGICA — INTENSIDADE GUIA A CONDUTA



AVALIAÇÃO DA DOR

TRIAGEM RÁPIDA E REPETIDA

- Intensidade (0-10), características (somática/visceral/NEUROPÁTICA), localização, fatores agravantes
- Impacto no sono, humor e atividades; exame físico dirigido
- Identificar e tratar a CAUSA (infecção, obstrução, fratura patológica, compressão)
- Dor aguda intensa = prioridade clínica — tratar prontamente e reavaliar até o controle
- Princípios da OMS: 'pela boca' (VO quando possível), 'pelo relógio' (horário fixo), 'pela escada'

ANALGÉSICOS NÃO OPIOIDES E ADJUVANTES

Fármaco	Dose orientativa	Observação
Paracetamol	500-1000 mg VO 6/6h (máx 3-4 g/dia)	Coadjuvante seguro; hepatotoxicidade em dose alta
Dipirona	500-1000 mg VO/IV 6/6h	Cautela em risco hematológico
AINE (ibuprofeno/naproxeno)	Ibuprofeno 600 mg 8/8h	Cuidado renal/GI; útil em dor óssea
Dexametasona (adjuvante)	4-8 mg/dia VO/IV	Infiltração tumoral, edema, compressão

OPIOIDES FORTES — BASE DA DOR MODERADA A SEVERA

Rx TITULAR ATÉ O ALÍVIO (sem teto fixo)

Morfina (padrão): VO 5-15 mg 4/4h (opioide-naïve); IV/SC 2-5 mg 2-4h na dor aguda intensa; sem dose-teto — titular
Oxicodona: VO 10-20 mg 12/12h; alternativa quando morfina não tolerada
Metadona: VO 2,5-10 mg 8-12/12h — titulação difícil (meia-vida longa/variável), exige experiência
Opioide fraco (Tramadol 50-100 mg 4-6h, máx 400 mg/dia): dor moderada/transição — NÃO isolado na dor severa
SEMPRE prescrever laxante (constipação não tem tolerância) + antiemético no início; vigiar sedação/depressão respiratória
Não atrasar opioide forte na dor severa — pode-se 'pular degraus'

ADJUVANTES POR TIPO DE DOR

Tipo de dor	Adjuvante
Neuropática	Gabapentina 300 mg/noite -> 900-2400 mg/dia; Pregabalina 50-75 mg 2x -> 150-300 mg/dia; Duloxetina 30-60 mg; Nortriptilina 10-25 mg
Óssea/metastática	Bisfosfonato/denosumabe; RADIOTERAPIA antálgica; AINE/corticoide
Inflamatória/compressão	Corticoide (dexametasona)
Refratária	Técnicas intervencionistas (bloqueios, analgesia intratecal); cuidados paliativos

ROTAÇÃO DE OPIOIDES — QUANDO E COMO

TROCA DE OPIOIDE/VIA (tolerância cruzada INCOMPLETA)

- Indicações: dor mal controlada apesar da dose, efeitos adversos intoleráveis, necessidade de outra via (sem VO), barreiras de acesso, comorbidade (ex.: DRC -> opioide sem depuração renal)
- Passo 1: converter a dose diária do opioide atual em equivalente de MORFINA ORAL e, daí, para o novo opioide (usar tabela de equipotência)
- Equipotência: morfina 10 mg IV = 10 mg SC = 30 mg VO (parenteral 3x mais potente que oral)
- Passo 2: REDUÇÃO automática de 25-50% da dose (tolerância cruzada incompleta); ~50% se idoso/frágil/dose alta, ~25% se sem fatores de risco
- Passo 3: dose de RESGATE 5-15% da dose total diária (ou 1/10 a 1/6) com opioide de ação rápida + monitorar de perto
- Metadona/buprenorfina: equipotência NÃO linear; metadona com meia-vida longa (8-120h) -> ajustes a cada 3-7 dias (risco de intoxicação)

RED FLAGS / MONITORIZAÇÃO

SEGURANÇA

- Reavaliar a dor a cada 30-60 min (IV) ou < 4h (VO) após a titulação inicial
- Vigiar sedação e DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA; ter naloxona disponível
- Metadona: alívio em < 48h após ajuste sugere risco de intoxicação (acúmulo) — ir devagar
- Compressão medular (dor + déficit) ou dor irruptiva severa = emergência -> imagem/dexametasona/RT, analgesia intensiva
- Prevenir constipação (laxante de rotina) e náusea; ajustar em disfunção renal/hepática

CHECKLIST

NÃO ESQUECER

- ☐ Medir intensidade e impacto funcional; tratar a causa tratável
- ☐ Escalonar conforme a dor; opioide forte sem demora na dor severa (titulação rápida)
- ☐ Adjuvante conforme o tipo (neuropática -> gabapentinoide/antidepressivo; óssea -> RT/bisfosfonato)
- ☐ Rotação: converter p/ morfina oral -> novo opioide -> reduzir 25-50% -> resgate 5-15%
- ☐ Laxante + antiemético de rotina; reavaliar e encaminhar a cuidados paliativos se complexa

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente oncológico com dor ____ /10, tipo ____ (nociceptiva/neuropática/mista); causa: ____.
- Opiode atual ____ (dose diária ____); efeitos adversos: ____; necessidade de rotação/via: ____.
- Conduta: opioide forte titulado + adjuvante ____; rotação realizada (novo opioide ____, dose reduzida ____, resgate ____).
- Encaminhamento a cuidados paliativos/dor se refratária ou complexa.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente oncológico com dor severa (9/10) por metástase óssea. Qual a conduta analgésica?

- A) Apenas paracetamol e reavaliar em 24h
- B) Iniciar opioide forte (ex.: morfina) com titulação rápida + adjuvantes (AINE/corticoide, considerar radioterapia antálgica)
- C) Tramadol isolado
- D) Aguardar avaliação ambulatorial
- E) Somente medidas não farmacológicas

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Ao realizar rotação de opioides, qual a redução de dose recomendada pela tolerância cruzada incompleta?

- A) Aumentar a dose em 25%
- B) Reduzir a dose total diária em 25-50% (mais próximo de 50% se idoso/frágil/dose alta)
- C) Manter a mesma dose
- D) Reduzir 90% sempre
- E) Não há necessidade de ajuste

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a equivalência analgésica da morfina entre as vias?

- A) 10 mg IV = 10 mg VO
- B) 10 mg IV = 10 mg SC = 30 mg VO (parenteral ~3x mais potente que oral)
- C) 30 mg IV = 10 mg VO
- D) As vias são equivalentes
- E) A via oral é mais potente que a IV

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Por que a metadona exige cuidado especial na titulação?

- A) Por não ter efeito analgésico
- B) Por meia-vida longa e variável (8-120h) e equipotência não linear, com risco de intoxicação por acúmulo
- C) Por ser eliminada apenas pelo rim
- D) Por não causar depressão respiratória
- E) Por ser um agonista parcial fraco

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual cuidado deve acompanhar SEMPRE a prescrição de opioides?

- A) Restrição hídrica
- B) Prescrição de laxante (constipação não desenvolve tolerância) e antiemético no início
- C) Suspender adjuvantes
- D) Evitar doses de resgate
- E) Jejum prolongado

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor severa oncológica indica opioide forte (morfina) com titulação rápida, sem 'subir degraus' lentamente. Em dor óssea metastática, associam-se AINE/corticoide e considera-se radioterapia antálgica e bisfosfonato/denosumabe.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Pela tolerância cruzada incompleta, reduz-se a dose total diária em 25-50% ao rotacionar (mais próximo de 50% em idosos, frágeis ou em altas doses), prescrevendo doses de resgate (5-15%).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A morfina parenteral é ~3x mais potente que a oral: 10 mg IV = 10 mg SC = 30 mg VO. Essa relação é essencial na conversão de vias durante a rotação de opioides.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A metadona tem meia-vida longa e imprevisível (8-120h) e equipotência não linear; ajustes devem respeitar 3-7 dias entre doses, pois alívio em < 48h sugere risco de acúmulo/intoxicação.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Todo paciente em opioide deve receber laxante profilático (a constipação opioide não desenvolve tolerância) e antiemético no início; vigia-se sedação/depressão respiratória.

SM24
Suporte ao Plantão Médico